

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT (ZBI)

Eje IV: Dinámica Familiar y Apoyo Social • Estándar Oro de Sobrecarga en Cuidadores Informales

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit (ZBI; Versión de 22 reactivos).
Nombre Original	Zarit Burden Interview (ZBI; Zarit, Reeve & Bach-Peterson, 1980).
Autores Originales	Steven H. Zarit, Ph.D., Karen E. Reeve, Ph.D. y Julie Bach-Peterson (Penn State Univ.).
Adaptación Hispana	María Martín, B. Salvadó, S. Nadal et al. (1996); Hospital Universitari Vall d'Hebron, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Familia y Cuidado. Sobrecarga subjetiva y estrés del cuidador principal informal.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme o administrado mediante entrevista clínica semiestructurada.
Formato de Respuesta	Escala Likert de 5 niveles de frecuencia (0 = Nunca a 4 = Casi siempre).
Población y Rango	Cuidadores familiares informales (≥ 18 años) de pacientes dependientes con demencia o ictus.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos de cumplimentación autónoma o guiada.
Régimen de Licencia	Copyright Mapi Research Trust; uso clínico/académico autorizado bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL ESTRÉS CRÓNICO EN EL CUIDADOR FAMILIAR

La **ZBI** fue concebida por Steven Zarit (1980) para evaluar el impacto multidimensional del cuidado crónico en el ámbito familiar:

- La Carga Subjetiva como Constructo Central:** Distingue la carga objetiva (número de horas invertidas o tareas físicas realizadas) de la **sobrecarga subjetiva** (la percepción emocional del cuidador sobre cómo la dependencia de su familiar compromete su propia salud, intimidad, estabilidad económica y bienestar psicológico).
- Síndrome del Cuidador Quemado:** La sobrecarga crónica no aliviada conduce inexorablemente al colapso afectivo (ansiedad, depresión), somatizaciones físicas, claudicación de la capacidad de cuidado e institucionalización precoz del paciente.
- Operatividad en Psicogeriatría:** Diseñada primordialmente para familiares de ancianos con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, es igualmente aplicable a cuidadores de pacientes con daño cerebral adquirido o esquizofrenia.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (22 ÍTEMS)

Dimensión del Impacto	Ítems ZBI	Contenido y Criterios Evaluados en la Escala
1. Impacto en Vida Personal	Ítems 2, 3, 11, 12	Falta de tiempo libre, pérdida de privacidad, abandono de relaciones sociales e independencia.
2. Sobrecarga Emocional	Ítems 1, 4, 5, 9, 18	Vergüenza, enfado, tensión interior, irritabilidad y miedo por el futuro del paciente.
3. Fatiga y Deterioro Físico	Ítems 10, 14, 19	Agotamiento corporal, deterioro de la propia salud física y sensación de sobreesfuerzo.
4. Relación con el Paciente	Ítems 6, 16, 20, 21	Deterioro de la relación previa, sensación de manipulación, pérdida de control del rol.
5. Carga Económica y Dependencia	Ítems 7, 8, 13, 15	Falta de recursos monetarios para cuidados, sensación de dependencia mutua forzada.
6. Juicio Global de Sobrecarga	Ítems 17 y 22	Deseo de ceder el cuidado a terceros (ítem 17) y sobrecarga general percibida (ítem 22).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de referencia de Martín et al. (1996; $N = 214$ cuidadores principales) avala una solidez psicométrica excepcional:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.91 - 0.93	Homogeneidad unifactorial robusta en los 22 reactivos en cuidadores españoles.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.86 - 0.89	Alta fiabilidad en reevaluaciones a 2 y 4 semanas en cuidadores sin cambios en soporte.
Validez Concurrente	$r = 0.72$ (GHQ-28)	Fuerte correlación directa con malestar psíquico y morbilidad psiquiátrica del cuidador.
Convergencia Clínica	$r = 0.65$ (HAM-D)	Asociación significativa con sintomatología depresiva y anhedonia en el cuidador.
Sensibilidad Terapéutica	Tamaño efecto $d = 0.78$	Sensible al alivio de sobrecarga tras programas de respiro familiar y centros de día.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

• **Opciones de Respuesta:** Escala ordinal de frecuencia de 5 niveles calificada de 0 a 4 puntos:

- 0 = Nunca
- 1 = Rara vez
- 2 = A veces
- 3 = Bastante a menudo
- 4 = Casi siempre

• **Cálculo de la Puntuación Directa Total (PD):** Suma aritmética lineal de las respuestas a los 22 reactivos:

$$\text{Puntuación Total ZBI} = \sum_{i=1}^{22} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 88 puntos})$$

• **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación directa, **mayor sobrecarga subjetiva** y mayor riesgo de claudicación en los cuidados. Puntuaciones < 47 reflejan adaptación sin claudicación.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Rango ZBI	Nivel de Riesgo	Estado Clínico del Cuidador (Martín et al., 1996)
Sin Sobrecarga	0 a 46 pts	Riesgo Mínimo	Cuidador compensado; recursos de afrontamiento y soporte familiar suficientes.
Sobrecarga Leve	47 a 55 pts	Alerta Preventiva	Signos de fatiga física y estrés emocional; riesgo incipiente de claudicación.
Sobrecarga Intensa	56 a 88 pts	Claudicación Inminente	Colapso del cuidador; elevada comorbilidad ansioso-depresiva; necesidad de respiro.

PUNTO DE CORTE DE CLAUDICACIÓN DEL CUIDADOR (ZBI ≥ 56 PUNTOS):

En la validación española de Martín et al. (1996), el punto de corte de **56 puntos** demostró una sensibilidad del 86% y una especificidad del 85% para predecir morbilidad psiquiátrica clínica en el cuidador y predecir la necesidad de institucionalización urgente del paciente dependiente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE GESTIÓN CLÍNICA Y APOYO AL CUIDADOR EN PSICOGERIATRÍA

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR CON ESCALA ZBI:

- **Paso 1 (Detección en Consulta de Geriatría / Neurología / Primaria):** Aplicar la ZBI a todo cuidador principal informal de dependiente crónico.
- **Paso 2 (Estratificación de Intervenciones):**
 - **ZBI entre 47 y 55 (Sobrecarga Leve):** Incorporar al cuidador a grupos psicoeducativos de manejo conductual de demencia y entrenamiento en autocuidado.
 - **ZBI $\geq$ 56 (Sobrecarga Intensa):** Activar de urgencia programa de respiro familiar (ayuda a domicilio, centro de día o estancia temporal).
- **Paso 3 (Atención a Síntomas Propios):** Si el cuidador puntúa $\geq$ 3 en ítems de salud física (ítem 10) o culpa (ítem 6), realizar despistaje de episodio depresivo y derivar a salud mental.
- **Paso 4 (Seguimiento Semestral):** Reevaluar cada 6 meses o tras cualquier empeoramiento clínico brusco del familiar.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN MULTIMODAL EN CLAUDICACIÓN DEL CUIDADOR DE ALZHEIMER

Identificación: Mujer de 51 años, administrativa con reducción de jornada, cuidadora principal de su madre de 79 años con Demencia tipo Alzheimer en fase moderada (GDS 5) con episodios de deambulación nocturna y agitación vespertina. La cuidadora acude a consulta médica por insomnio grave, llanto inmotivado y lumbalgia crónica.

Evaluación Inicial ZBI:

- **Puntuación Total ZBI = 68 / 88 puntos (Sobrecarga Intensa / Claudicación Inminente, Percentil 90).**
- **Ítems Críticos (puntuación 4 - Casi siempre):** Ítem 2 (Falta de tiempo propio), Ítem 10 (Deterioro de la salud), Ítem 11 (Pérdida de vida social), Ítem 18 (Sentimiento de pérdida de control) e Ítem 22 (Sobrecarga global extrema).

Intervención Sociosanitaria Integral:

1. **Soporte Formal:** Tramitación urgente de plaza en Centro de Día para la madre (de 9:00 a 17:00 h) y servicio de ayuda a domicilio matutino para higiene.
2. **Tratamiento Médico:** Ajuste neurológico de la madre (Trazodona para insomnio nocturno) y soporte psicológico individual para la cuidadora (reestructuración del sentimiento de culpa y establecimiento de límites familiares con sus hermanos).

Reevaluación a los 4 Meses: La puntuación ZBI descendió a **38 / 88 puntos (Sin Sobrecarga / Rango Compensado)**. La cuidadora normalizó el sueño, retomó actividades deportivas semanales y recuperó la paciencia afectiva con su madre.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO DE MALTRATO O NEGLIGENCIA: Un ZBI $>$ 65 con hostilidad verbal explícita alerta sobre riesgo inminente de negligencia o maltrato no deliberado por agotamiento extremo.

CULPA OCULTA Y NEGACIÓN: Cuidadores con altos niveles de autoexigencia pueden minimizar la puntuación por culpa; cotejar con indicadores fisiológicos de estrés y cansancio objetivo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Zarit, S. H., Reeve, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. *The Gerontologist*, 20(6), 649-655.
2. Martín, M., Salvadó, I., Nadal, S., et al. (1996). Adaptación para nuestro medio de la Escala de Sobrecarga del Cuidador (Caregiver Burden Interview) de Zarit. *Revista de Gerontología*, 6, 338-346.
3. Bédard, M., Molloy, D. W., Squire, L., Dubois, S., Lever, J. A., & O'Donnell, M. (2001). The Zarit Burden Interview: A new short version and screening test. *The Gerontologist*, 41(5), 652-657.
4. Albers, G., et al. (2010). Evaluation of the Zarit Burden Interview in families of palliative care patients. *Journal of Pain and Symptom Management*, 40(6), 852-863.